

23 - Histo séance 1

Alors, toujours classer l'épithélium. Regardez, on a un épithélium qui a plusieurs couches. Lorsqu'on a plusieurs couches, qu'est-ce qu'on prend en considération pour classer, pour qu'il donne la forme de l'épithélium ? Voilà, ça c'est la lame basale, toujours l'épithélium qui repose sur une membrane basale qui le sépare du tissu conjonctif sous-acide.

Très bien, bravo. Effectivement, c'est un épithélium qui est pavimenteux, donc qui va juger au niveau de la forme. C'est la couche la plus superficielle qui va nous donner la forme.

La couche la plus superficielle, il est pavimenteuse, et on a un épithélium qui est stratifié. Donc c'est un épithélium qui est pavimenteux, stratifié. Très bien.

Toujours les mêmes gens qui répondent très bien. Kinza, bravo Kinza. Très bien, Issa Mohamed.

Oussama, très bien. Alors toujours classer l'épithélium. Donc on aura, voilà, il faut bien voir s'il vous plaît.

Il faut répondre rapidement. L'essentiel c'est de répondre juste. Très bien, bravo.

Bravo, très bien. L'épithélium qui est pseudo-stratifié, oui, mais qu'il y a des cils, très bien. Il est pseudo-stratifié, cilier.

Bravo, très bien. Toujours les mêmes. Très bien.

Alors il y a Kinza qui est toujours la première. Alors, regardez bien cette gronde là. Regardez.

Le canal, il est là. Il est formé, il est ramifié, il est formé de plusieurs doses. Donc, qu'il s'agit qu'une gronde.

Très bien, bravo. Effectivement, c'est une gronde qui est exocrine parce qu'on a un canal excréteur et ce canal est bien ramifié et c'est une gronde qui est composée. Très bien, bravo.

Donc on va laisser les résultats jusqu'à la fin. On va faire maintenant passer les questions. On laisse un petit peu de ce qu'il perd.

Regardez aussi là. On a une gronde qui est toujours exocrine. Il faut la classer aussi.

Voilà le canal excréteur. Voilà, un aspect qui est aussi particulier. Très bien.

Très bien. C'est une gronde qui est effectivement tubuleuse mais qui a un aspect particulier et qui est courburenée, tortueuse et qui est ramifiée parce qu'on a à partir de l'oeuf qu'elle est ramifiée. Très bien.

Regardez bien. La lumière est bien visible. Le noyau est refoulé vers la basale et il est raflaté.

Et de cette place, il est riche en bracuoles qui sont blancs, qui sont remplies, transparentes. Donc il s'excrète quoi ? De mucus. Très bien.

Donc c'est muqueuse et de mucus. C'est un type liquidien. Il n'y a pas d'enzyme.

Effectivement, ça ressemble à l'eau et à des électrolytes. Elle est de type muqueuse. On va laisser les résultats jusqu'à la fin.

Ici, c'est un mode de sécrétion. Quel type de mode de sécrétion ? Regardez bien. La bracuole est là.

Elle va prendre une partie du pôle apical de la cellule et qui va être aussi sécrétée avec le contenu. Très bien. Donc, apocrine, il y a une perte de l'intégrité de la cellule qui est partielle.

Le pôle apical, il est parti avec la sécrétion. Très bien. C'est un équitérium.

Vous devez les classer. Voilà la couche la plus superficielle. Regardez ici ce qu'on a. Il faut classer cet équitérium.

Voilà l'équitérium. Voilà la couche superficielle. Voilà la couche profonde.

Et les pavements sont stratifiés, kératinisés. Il y a des ramènes de kératine qui se détachent sur la partie superficielle. Bravo.

Alors, ça, il faut bien le voir. L'équitérium, quel que soit, repose directement sur quoi ? Directement. Donc, directement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équitérium.

Regardez ça dans la tête. On ne trouvera jamais un équitérium sans membrane basale et sans tissus conjonctif sous jason. Parce que l'équitérium, c'est un tuque.

L'ensemble du tuque est polarisé et repose sur un tissu conjonctif. Donc ce tissu, il est séparé de l'équitérium toujours par une membrane basale. L'équitérium ne repose pas directement sur le tissu conjonctif.

Il le repose par l'intermédiaire d'une membrane basale. À travers cette membrane basale, il va passer les nutriments, tout ce qu'il a, les échanges qu'il a avec le tissu conjonctif. Très bien.

On va passer, on laisse le résultat à la fin. Le voix. Le voix est une langue.

Qu'est-ce qu'il type ? Est-ce qu'il est endocrine ? Est-ce qu'il est exocrine ? Est-ce qu'il est apocrine ? Est-ce qu'il est homo- ou hétéro-typique ? Très bien. Déjà, on trouve que le pourcentage le plus incontournable... Qu'est-ce que ça veut dire enficrine ? Ça veut dire qu'il fait les deux rôles. Endocrine et exocrine à la fois.

Donc, le voix, il fait les deux rôles. Le rôle exocrine de la voix, c'est la ville qui est sécrétée par

l'hépatocyte et qui est libérée vers le tube digestif. Tout ce qui est en communication avec l'extérieur.

Et le rôle endocrinien qui est aussi assuré par l'hépatocyte, qui libère les facteurs plasmatiques, qui libère les plus bons leçons, qui vont agir à un autre niveau. Donc, c'est la même cellule pour laquelle on appelle endotypique. Ça veut dire que c'est la même cellule qui fait à la fois le rôle endocrine et à la fois le rôle exocrine.

Hétéro-typique, ça veut dire qu'elle est aussi exocrine et endocrine, mais on aura des cellules qui vont faire le rôle exocrine et d'autres types de cellules qui vont faire l'endocrine. C'est pas la même cellule. Hétéro-typique, c'est l'exemple du pancréas.

Très bien. Déjà, on trouve que les réponses justes sont majoritaires. Très bien.

Les glandes endocrines sécrètent des hormones, emportent des canaux excréteurs, élaborent un produit mutuel, élaborent un produit sur eux, sont non-vascularisées. Qu'est-ce qu'ils font, les glandes, lorsqu'on dit endocrines ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de canaux, les sécrétions sont directement dans le sang. Effectivement, elles élaborent des hormones.

Très bien. La majorité, donc, 90%, elles ont répondu juste dans 80%. C'est juste.

On va passer. Donc, ici, un autre monde de sécrétions. Voilà la cellule, elle commence à produire.

Les produits sont là. Au fur et à mesure, elles se produisent. La membrane cytoplasmique, c'est le premier qui se dégrade.

Oui, le noyau, lorsqu'il est libéré. Très bien. Donc, c'est holocrine.

Puisque la moitié, 62%, ils ont répondu juste, c'est très bien. Donc, c'est holocrine. Alors, une question.

Alors, les glandes exocrines. Exo. Est-ce qu'ils sécrètent des hormones? Est-ce qu'ils l'ont vascularisé? Elles abordent des produits sévères aux liqueurs.

Elles abordent leurs produits dans le sang. Très bien. Donc, les 2 tiers, ils ont répondu juste, très bien, donc, effectivement, exocrine, c'est dans l'extérieur.

Donc, c'est pas les hormones. Les hormones, c'est à l'intérieur. C'est dans le sang.

Lorsqu'on parle des glandes, ça veut dire que c'est un épithélium plus un tissu conjonctif qui le soutient. Le tissu conjonctif qui le soutient est vascularisé. Donc, ils ne sécrètent pas leurs produits dans le sang.

Leurs produits, ils les sécrétaient vers l'extérieur. Soit directement, soit indirectement. C'est pour

cela qu'on l'appelle exocrine.

Donc, la dernière, on va voir la fuite. Donc, regardez ici. C'est une glande exocrine.

Regardez, il faut la classer. Le canal excréteur, elle est là. L'unité sécrétrice, elle est là.

Est-ce que c'est tubuleuse droite ? Est-ce que c'est acineuse ? Tubuleuse simple contournée, alvéolaire simple ou tubuleuse ramifiée contournée ? Très bien. Plus que le tiers, ils ont répondu juste, très bien. On voit qu'il y a des tubuleuses qui sont contournées, mais qui sont simples, ça veut dire qu'elles ne se ramifient pas.

Elles ne sont pas droites. Droite, c'est comme ça, un trait. Acineuse, c'est des acinides.

On va voir la structure après. Alvéolaire, non, est tubuleuse. Elle n'est pas ramifiée.

Ramifiée, elle doit se diviser. Elle doit donner des ramifications. On va voir le dernier.

Je pense que c'est très bien. C'est Selma. Selma, tu es là ? Oui, monsieur, je vous entends.

Très bien. On va passer à notre test maintenant. Si vous voulez, vous aurez des questions à réponse multiple.

C'est du QCM. C'est le même type du QCM qu'on pose à l'examen. On va prendre et on va passer par ça.

On va un petit peu les choses simples. On va d'abord parler à notre code, s'il vous plaît. Toujours le même principe.

Entrez Monty. Maintenant, le code, il est différent. D'accord ? Monty.com Allez, connectez-vous, s'il vous plaît.

Maintenant, vous serez habitués avec moi et on va faire ça de façon systématique. Très bien. Allez, connectez-vous.

Je vous donne une ou deux minutes pour se connecter. Après, on commence. Le code 69 4704 94.

On va commencer. C'est presque le même nombre d'heures. Une fois, on arrive à 30, on commence.

On va commencer. Tout d'abord, c'est des questions pour Silly Quiz. Le code que je vais vous donner, Avant de rentrer dans les usines.

Alors, l'histologie, c'est la science qui étudie quoi ? Histo, logique ? Donc, historologie, ichthologie, c'est la science, et l'histologie ça va être la science qui étudie les tissus. Très bien, donc la science qui étudie les cellules c'est la cytologie ou la biologie des cellules. Très bien,

donc ça c'est des questions simples, on va les faire passer rapidement.

Alors le tissu, il se définit comment ? Vous allez pouvoir avoir une petite réflexion. C'est quoi le tissu ? Un tissu, pourquoi ? Très bien, un ensemble de cellules du même origine qui vont se regrouper autour de la même fonction. C'est ça un tissu.

Donc un tissu égal, un ensemble de cellules qui sont de la même origine qui vont se regrouper autour de la même fonction. Très bien, alors l'organe c'est quoi ? Bon quand tu es sur des choses spontanémentales, l'organe c'est quoi ? C'est un ensemble de tissus. Très bien, donc l'organe c'est un ensemble de tissus.

Un ensemble de cellules c'est un tissu. Un ensemble de tissus c'est un organe. Un ensemble d'organes c'est un système ou un appareil.

Alors le tissu épithélial, c'est un tissu, est-ce qu'il est fondamental, est-ce qu'il est conjonctif ? Alors, c'est un tissu, il ne faut pas confondre les choses. Très bien, c'est un tissu fondamental. Donc les tissus fondamentaux sont quatre, épithélial, conjonctif, musculaire et nerveux.

Et le tissu conjonctif, il est le tissu conjonctif ordinaire et le tissu conjonctif spécialisé. Le tissu conjonctif spécialisé, c'est le tissu cartilagineux, le tissu pousseur, le tissu adéquat et le tissu sans perte. Alors ça, ça ressemble au corps.

Très bien. Donc, je pense que c'était Daos qui va gagner. Très bien pour Daos.

Donc, voilà, je viens de le citer, ici c'est la question choix multiple. Donc les tissus conjonctifs spécialisés sont ? Les tissus conjonctifs spécialisés. Alors répondez, il y a toujours des gens qui n'ont pas encore répondu.

Donc maintenant vous devez répondre et envoyer la réponse. Et pas seulement cocher. C'est cocher, vous faites envoyer.

Très bien. Donc, les tissus conjonctifs spécialisés. Très bien.

Donc voilà, on enlève le tissu nerveux qui est un tissu fondamental. Et les tissus conjonctifs spécialisés sont le tissu pousseur, le tissu sanguin, le tissu cartilagineux et le tissu adéquat. Donc, Phil Daos qui va gagner, il n'y aura pas de problème.

Très bien, Phil Daos. Donc maintenant, on va passer à autre chose. Je pense que c'est déjà fait.

Très bien. Alors, c'est ça, on va voir. Entrez le code, voilà.

Entrez le code d'abord. Entrez le code, toujours la même chose. Entrez le code et c'est des questions à choix multiple.

Monty.com et vous rentrez le compte et vous serez connecté. Maintenant, il n'y a personne qui

est connecté avec moi. Très bien.

Ça commence à apparaître. Allez, connectez-vous. 59035124.

Connectez-vous et répondez, envoyez la réponse. Donc maintenant, c'est le même type de question. Vous aurez un examen sur le même principe.

Très bien. Le code, s'il vous plaît. Voilà.

59035124. Voilà. Toujours une seule fiche à côté du site.

Voilà. Très bien. Donc, le tissu péritentiaire est un ensemble de cellules jointives, juxtaposées, polarisées, qui ne reposent pas directement sur le tissu conjonctif, qui reposent à travers l'embrain nasal.

Effectivement, c'est un tissu fondamental qui est non-vascularisé et non-binaire. Donc, si on veut définir le tissu péritentiaire, c'est un ensemble de cellules jointives, juxtaposées, polarisées, qui reposent sur une membrane nasale qui le sépare du tissu conjonctif sous-jacent. Est-il un tissu qui est non-vascularisé, non-binaire ? Très bien.

Les deux réponses justes, celle-là et celle-là. On passe. Donc, ici, il n'y a pas de compétition.

L'essentiel, c'est de répondre juste. Les critères de classification des hypothéliums de revêtement reposent sur le sang. Alors, les hypothéliums de revêtement, ce sont les mêmes types de questions que vous aurez à l'exemple.

Très bien. Bravo. Donc, il y a trois critères.

La forme de la cellule, le nombre de couches cellulaires et la différenciation apicale qui est imposée. Le mode de sécrétion, c'est la nature du produit sécrétant. C'est un critère de classification des glandes, des hypothéliums glandulaires.

Ce n'est pas une classification des hypothéliums de revêtement. Très bien. Voilà les réponses justes qui restent affichées.

Très bien. La majorité, ils ont répondu juste. La plupart, ils ont répondu juste.

Il reste que 141. La majorité, ils ont répondu juste. Alors, on va passer parmi les fonctions des hypothéliums de revêtement.

On note la protection et l'absorption. Alors, vous répondez. Vous ne pouvez pas être influencé par vos amis.

Il faut faire des choses pour que vous soyez influencé. Très bien. Donc, la protection qui peut être de type mécanique ou biochimique ou des choses comme cela, thermique.

Effectivement, les hypothéliums, ils peuvent avoir un mode d'absorption. Effectivement, ils peuvent avoir un mode d'échange. Non, la nutrition, non, parce qu'eux qui vont recevoir la nutrition parce qu'ils ne sont pas vascularisés, donc, ils ne peuvent pas nourrir d'autres.

Donc, pour eux, il dépend de la nutrition, il dépend du tissu conjonctif, ce que je sens. Eh bien, d'ailleurs, le déplacement par les cils, c'est pour ça qu'ils vont déplacer les choses qui vont subvertir. Très bien.

Donc, c'est quatre propositions qui sont justes. Nutrition et défense. Donc, parmi les modes de sécrétion.

Maintenant, on passe dans les modes du système glandulaire. Parmi les modes de sécrétion, il faut bien, s'il vous plaît, saisir les choses. Maintenant, vous avez fait une chose de façon vague.

Effectivement, il y a les modes apocrine, mérocrine et holocrine. Mais, par diffusion et exocytose, ils font partie du mode mérocrine. Donc, ils sont aussi, c'est un mode de sécrétion.

On peut dire que c'est un sous-mode. Mérocrine, ça veut dire qu'il peut être par diffusion ou par exocytose. Donc, toutes les propositions sont justes.

Parce que mérocrine, elle comporte aussi par diffusion et par exocytose. Si vous voyez le cours, il y a l'apocrine. L'intégrité de la cellule, elle est partiellement... Donc, il perd l'intégrité partielle.

Mérocrine, il garde son intégrité après la sécrétion. Et holocrine, il y a une perte totale de l'intégrité de la cellule après la sécrétion. Parmi les modes qui font partie de mérocrine, on aura par diffusion, les choses vont diffuser de façon pression, des choses comme ça, et par exocytose, où il n'y aura pas de modification de la cellule après la sécrétion.

Donc, toutes les propositions sont justes. D'accord ? Donc, exocytose et par diffusion, ils font partie du mode mérocrine. Donc maintenant, vous avez bien la classification des glandes exocrines.

Pour bien dire, s'il vous plaît, ce que vous avez assumé au cours. Très bien. Donc, les réponses justes sont la nature du produit sécrété, qui peut être séreuse, niqueuse ou mixte.

Le mode de sécrétion qui peut être holocrine, mérocrine, apocrine et par mérocrine, on a diffusion et exocytose. La morphologie de l'unité sécrétrice qui peut être tubuleuse, alvéolaire ou racineuse. Et la morphologie du canal excréteur qui peut être, d'abord, est-ce qu'il est présent ou pas ? Lorsqu'il est présent, est-ce qu'il est simple ou ramifié ? Très bien.

Donc, le nombre de bouches ne fait pas partie. Donc, le nombre de bouches cellulaires, c'est un critère de classification des épithélium ou de rovellum. Très bien.

Donc, on va partir maintenant. On va voir. Est-ce que vous avez des questions concernant le

tissu conjonctif, le tissu épithélial, avant de passer au tissu conjonctif ordinaire ? Si vous avez des questions, c'est le moment de poser concernant, pour laisser le passage.

Oui, vous-même. Monsieur, concernant la classification des bouches, on a une interclassification. C'est-à-dire, que ce soit l'amorphologie de l'unité sécrétrice et le canal.

Le canal excrète. D'accord, merci. Quand on dit l'amorphologie de l'ensemble de la demande, ça veut dire qu'il regroupe l'amorphologie de l'unité qui sécrète et l'amorphologie de l'unité qui excrète.

D'accord ? Allez. Si vous avez des questions pour les épithéliums de revêtement, c'est le moment de passer au tissu. Où est le tissu ? Le pancréas.

Oui. Comme une glande amphicrine. Une glande séreuse.

Et une glande séreuse. En même temps. Le voix, le pancréas, elle est à la fois exocrine et à la fois endocrine.

Le rôle d'exocrine, il est fait par les assinies séreuses. D'accord ? Le pancréas exocrine, c'est séreux, oui. C'est des assinies séreuses.

Et le pancréas endocrine, c'est les îlots de l'angélinse. Lorsqu'on regroupe pancréas exocrine et pancréas endocrine, ça donne le pancréas, qui est une glande amphicrine, ça veut dire à la fois endocrine et endocrine. Et hétérotypique, ça veut dire que ce n'est pas la même série d'endocrines.

C'est un cellule qui fait le rôle endocrine, qui va faire le rôle endocrinien et exocrinien en même temps. D'accord ? C'est bon. Merci.

Monsieur, je n'avais pas compris comment les épithélium de revêtement peuvent contenir des cellules globulaires. C'est très simple. Donc, on a un épithélium de revêtement.

D'accord ? Donc, lorsqu'il y a un épithélium, on peut avoir parmi les classifications, qu'on commence pour les épithéliums globulaires, on a un épithélium de revêtement qui peut contenir une cellule qui sécrète. On appelle une glande, ou la cellule globulaire, un cras épithélial de revêtement. D'accord ? On peut trouver des armes de cellule à l'intérieur de l'épithélium de revêtement qui fait le rôle qui sécrète.

Et comme on peut avoir tout l'épithélium de revêtement qui est globulaire, ça veut dire lorsque vous entendez le terme globulaire, égale quoi ? Lorsque vous entendez glande, égale quoi ? Glande égale sécrétion. Donc, cette sécrétion, elle peut être en intraépithélial. On peut avoir des cellules globulaires, des cellules sécrétoires intraépithéliales qui sécrètent dans l'épithélium de revêtement.

D'accord ? Comme on peut trouver tous l'épithélium de revêtement et les glandulaires. Dans ce cas-là, on n'aura pas de canal excréteur. Donc, c'est des cellules qui vont sécréter directement dans une lumière.

D'accord ? Si vous voyez la classification au niveau du cours, on commence d'abord par est-ce qu'il est unicellulaire ou pluricellulaire. S'il est unicellulaire, il est en intraépithélial dans l'épithélium de revêtement. Pluricellulaire, est-ce que c'est mineur, est-ce que c'est majeur ? Donc, est-ce que c'est déconfiné essentiellement dans le tissu conjoint ? D'accord ? Effectivement, les cellules de l'épithélium de revêtement, elles peuvent contenir des cellules glandulaires, une, plusieurs, pour tous les épithéliums qui pourraient être glandulaires.

Ça veut dire, lorsqu'on vos rencontre et tout, c'est secrète. D'accord. Merci, prof. Merci.

Monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Quelle est la signification d'épithélium pseudostratifié de transition ? Alors, qui peut me définir un épithélium pseudostratifié ? C'est quoi ? D'accord, pseudostratifié.

C'est un organe pression qui est stratifié, mais en réalité, toutes les cellules, elles ont un point d'attachement au niveau de la membrane basale. D'accord ? C'est ça le terme pseudostratifié. D'accord ? Donc, lorsqu'il est pseudostratifié, on ne le classe pas.

Donc, il est pseudostratifié. D'accord ? Oui, professeur. D'accord.

Et transition, ça veut dire que c'est un type particulier urinaire qui est de transition, mais ça reste pseudostratifié. Alors, vous avez des questions ? Monsieur ? Oui ? L'épithélium gland. Est-ce que la création du gland d'exocrine selon le critère morphologique se base surtout sur la présence ou l'absence du canal excréteur ? Bien sûr.

Donc, première chose, lorsqu'on a une sécrétion, on doit d'abord voir s'il y a des cellules en intraépithélial qui sécrètent. Dans ce cas-là, on n'a pas de canal. Les cellules sécrètent directement dans l'épithélium, dans la lumière.

Et si on a un canal excréteur, d'accord ? On va voir s'il y a un seul canal qui alimente vers la lumière et ça va être simple, ou il va se ramifier en plusieurs. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on a d'abord un canal ou pas ? Il n'y a pas de canal, ça veut dire qu'on a des cellules épithéliales glandulaires à l'intérieur de l'épithélium de revêtement de surface.

D'accord ? Dans ce cas, on n'a pas besoin de canal. S'il y a un canal, ça veut dire que la glande est confinée dans le tissu conjonctif sous-jacent. Si on a un seul canal qui fait communiquer la glande avec la lumière, c'est simple.

Lorsque ce canal se ramifie en plusieurs branches, on aura une glande qui est ramifiée. D'accord ? D'accord, monsieur. Merci.

Merci. Vous avez des questions ? Alors, on va passer au tissu conjonctif ordinaire. Monsieur, s'il vous plaît.

Oui, je vous entends. S'il vous plaît. Quelle est la différence entre unité sécréterie et excréterie ? Alors, qui sécrète ? Ça veut dire l'unité qui va élaborer le produit.

D'accord ? Sécrète, il élabore. Excréterie, c'est le tuyau ou le canal qui va acheminer ce produit. D'accord ? Quand vous avez la source de l'eau, il y a une source.

La source, c'est quoi ? C'est sécrétoire. Sécrétoire. C'est sécrétoire.

Et les tuyaux qui vont acheminer tout ça, c'est quoi ? Excrétoire. Excrétoire. D'accord ? Donc, l'excrétoire, c'est l'acheminement.

D'accord ? C'est le canal. Et la source, où il vient, c'est la sécrétion. D'accord ? Oui, professeur.

Merci. Monsieur. Oui, bentit.

Monsieur, s'il vous plaît, l'absence du canal excréteur, cela dit que c'est une grande endocrine puisqu'il n'y a pas un canal qui fait relier l'épithélium. Là, bentit. Donc, on peut, à l'absence de canal, si on a une glande pluricellulaire confinée dans le tissu conjonctif, d'accord ? Fausse le tissu conjonctif.

Il doit se communiquer avec l'épithélium de revêtement, de surface, pour qu'il sécrète, parce que c'est l'exocrine. Dans ce cas-là, on aura besoin d'un canal. Si les cellules épithéliales sont en intraépithélial glandulaire, il est à l'intérieur du revêtement.

Est-ce qu'on aura besoin d'un canal ? Non. Non. Donc, lorsqu'on a l'exocrine, est-ce qu'il y a un canal ou pas ? Ça veut dire, est-ce que les cellules épithéliales qui sécrètent sont en intraépithélial, en intraépithélium de revêtement ? Par contre, en endocrine, ils doivent avoir, le principe des grandes endocrines, deux choses.

Le produit qui est sécrété, il est libéré directement vers quoi ? Dans le sang. Dans le sang. Pas d'intermédiaire.

C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien entre l'épithélium de revêtement et les grandes endocrines. Très bien. Dans l'endocrine, il n'y a pas de lien.

Donc, leur produit, il est dans le tissu conjonctif, qui le soutient. D'accord ? Donc, le sang, directement dans le sang. Par contre, tout ce qui est excrétrice, ça veut dire vers l'extérieur, soit directement, soit indirectement.

Donnez-moi des exemples des glandes exocrines, pures pour le corps. Donnez-moi des exemples des glandes exocrines. Donnez-moi des exemples.

Les glandes salivaires. Les glandes salivaires, oui. C'est exocrine, ici.

La glande mammaire. La glande mammaire, très bien. Donc, tout ce qui est vers l'extérieur, soit directement, soit indirectement.

Par exemple, tout ce qui est excrété par la bile, il est vers le tube digestif. Et le tube digestif, est-ce qu'il est communiqué avec l'extérieur ? D'accord ? Donc, soit, par exemple, les glandes qui excrètent la sueur, la sueur. Donc, ils le secrètent directement vers l'extérieur, par des canaux qui le libèrent directement.

D'accord ? Donc, c'est ça. Alors, on va voir, s'il vous plaît, maintenant. On va voir, est-ce que c'est ça ? Et donnez-moi des exemples des glandes endocrines.

La thyroïde. Très bien. La thyroïde.

Les glandes suranales. Très bien, bravo. Voilà, vous avez maintenant pu faire la différence entre ces glandes-là.

Donc, exocrine, gardez à l'esprit, il se communique avec l'extérieur. Soit directement, soit indirectement. Ça veut dire, soit il le secrète dans un tube qui est en communication vers l'extérieur, soit, par exemple, regardez, les glandes salivaires, ils secrètent la salive vers la cavité buccale, dans la cavité buccale.

Et la cavité buccale, elle est en communication avec quoi ? Avec l'extérieur. L'extérieur. Très bien.

D'accord, c'est ça. D'accord, elle est en communication avec l'extérieur. Donc maintenant, on va voir le tissu conjonctif.

Alors, tissu conjonctif. Je pense que c'est ça. Alors, un autre code, s'il vous plaît.

Alors, vous rentrez le code 38, 29, 38, 35. Maintenant, vous vous connectez rapidement. Ça veut dire, le message, maintenant, on a l'habitude de travailler comme ça.

Allez, connectez-vous. Il n'y a que 96. Allez.

On arrive à 130, toujours comme d'habitude. Donc 120, connecté. Très bien, allez.

Alors, dans quelques secondes, on va commencer. Allez, connectez-vous, s'il vous plaît. Allez.

Donc maintenant, on va prendre le tissu conjonctif ordinaire. Alors, maintenant. Bravo.

Donc, la majorité, c'est juste 98 %. Effectivement, le tissu conjonctif ordinaire, c'est un tissu de soutien. Il est fait de cellules qui sont non jointives. Il est vascularisé.

Il est innervé. C'est un tissu qui est ubiquitaire. Ça veut dire qu'on le trouve partout.

C'est le lieu des échanges avec les cellules. C'est la respiration cellulaire. C'est le lieu de la cicatrisation.

C'est le lieu, donc, du tissu conjonctif ordinaire. C'est le lieu où il y aura une infection. C'est le tissu.

Lorsqu'on a une plaie cutanée et il y a le sang qui est gros, ça veut dire qu'on est minimum au niveau du tissu conjonctif ordinaire. Donc, c'est un tissu de soutien. Très bien.

Le soutien, la protection. Très bien. Très bien.

Donc, oui. Un est le plus rapide. On va passer.

Donc, parmi les cellules fixes, le tissu conjonctif ordinaire, ça veut dire les cellules qui sont toujours là, fixes, qui définissent le tissu conjonctif ordinaire. Une seule proposition qui est juste, s'il vous plaît. Très bien.

Bravo. Donc, 87%. Très bien.

Ils ont répondu juste. Donc, fibroblast cellule fixe. Donc, d'abord, la cellule souche.

C'est la cellule mesenchymateuse qui va se différencier en fibroblast. Fibroblast, c'est la cellule principale du tissu conjonctif ordinaire. Cette cellule principale va se différencier, à la fin de sa vie, en fibrocyte, qui est une cellule inactive.

Et on peut avoir des cellules adipocytaires au sein de ce tissu conjonctif ordinaire. Donc, il y a quatre cellules fixes du tissu conjonctif ordinaire. Très bien.

On passe. Donc, maintenant, les cellules mobiles du tissu conjonctif. Très bien.

Ah, quatre fois. Très bien. Donc, toutes ces cellules-là, fibroblast, adipocytes, mesenchymateuse et fibrocytes, ce sont des cellules qui sont fixes.

Les leucocytes, c'est des globules blancs. Donc, ce sont des cellules qui sont mobiles. Très bien.

Bravo. Donc, c'est Selma qui va prendre la relève. On passe.

Alors, parmi les cellules mobiles autochtones, ça veut dire résidentes qui traversent et qui passent dans le tissu conjonctif et qui restent, et qui sont mobiles au sein du tissu conjonctif. Donc, il y a des cellules mobiles autochtones et il y a des cellules mobiles immigrées. Ça veut dire autochtones, c'est résidentes.

Elles sont mobiles au sein du tissu conjonctif ordinaire. D'accord ? Très bien. Donc, les cellules

nucléaires neutrophiles, ce sont mobiles, mais immigrées.

Ça veut dire qu'elles passent, elles reviennent. Elles passent lorsqu'on en a besoin. Elles traversent les capillaires.

Elles passent pour faire le rôle. Elles reviennent dans les capillaires. Les lymphocytes aussi.

Poules nucléaires éosinophiles et poules nucléaires basophiles. Les mastocytes, ils traversent, mais ils restent dans le tissu conjonctif et ils sont mobiles au sein du tissu. Comme les macrophages, lorsqu'ils traversent, ils deviennent histiocytes.

La même chose. D'accord ? Très bien. Voilà, vous êtes très bien.

Donc, on est toujours supérieur à 70% des réponses justes. Donc, les fibres élastiques. Vous connaissez, il y a trois types de fibres.

Il y a les fibres élastiques, fibres de collagène et fibres de réticuline. Donc, chacun avec ses caractéristiques. Les fibres élastiques, donc, elles ont la particularité d'être comment ? Allez, après on va définir.

Très bien. Bravo. Donc, les fibres élastiques, ce sont des fibres qui sont minces, qui se ramifient et peuvent s'anastomoser.

C'est comme un filet de maille. Un filet de maille. Et ils sont élastiques.

Et l'origine, ce n'est pas une fibre de collagène, c'est une fibre particulière élastique qui va donner une fibre élastique. Très bien. Bravo.

Donc, on est très bien. Donc, le message, il est très bien. Donc, c'est Mohamed, c'est le premier pour le moment.

On passe. Donc, c'est un tissu particulier. Regardez.

Il est vacuolaire. Il laisse traverser la lumière. C'est un tissu qui est cellulaire.

Très cellulaire. Donc, surtout ça, c'est des cellules. Et à l'intérieur, il y a des choses, mais qui sont invisibles.

Très bien. C'est un tissu adipeux. Donc, adipeux, c'est un tissu conjonctif spécialisé.

Quelle est sa spécialisation ? Pourquoi on l'appelle spécialisation ? Parce qu'il est spécialisé dans le stockage de la graisse. C'est un tissu qui est très vacuolaire. À l'intérieur, il y a de la graisse sous forme de liquide, d'huile.

Donc, l'huile, elle laisse traverser la lumière. C'est pour cela qu'on voit que c'est vacuolaire, comme ça, blanc. Effectivement, c'est un tissu adipeux.

Donc, regardez ici. Vous aurez un tissu conjonctif ordinaire. Regardez.

Il y a les cellules. Il y a la substance fondamentale. C'est le blanc.

Et il y a les fibres. Donc, il y a un équilibre entre les différentes constitutions. Il y a un équilibre.

Très bien. C'est un tissu conjonctif qui est lâche. Lorsqu'il y a un équilibre entre les différentes constitutions, ça veut dire qu'on va prendre les cellules et la matrice extracellulaire, les fibres.

Surtout les fibres. Si les fibres sont plus importantes que les cellules, on parle d'un tissu conjonctif fibreux ou dense. Lorsque les cellules vont la remporter, on parle d'un tissu conjonctif cellulaire.

C'est l'exemple du tissu adipeux. S'il y a un équilibre entre les différentes constitutions, ça veut dire que c'est égal, on parlera d'un tissu conjonctif qui est lâche. Donc, regardez la différence.

On a vu tout à l'heure qu'il est lâche. Et maintenant, on voit l'importance des fibres qui sont là. Donc, il est très fibreux.

Il est très dense. Les cellules. Donc, on trouvera que les fibres vont remporter la bataille.

Donc, c'est les fibres qui remportent la bataille. Très bien. Donc, dense, c'est les fibres qui remportent.

Lâche, c'est un équilibre. Cellulaire, c'est les cellules qui le remportent. Regardez, ça veut dire qu'on a presque terminé.

Donc, très bien. Alors, si Mohamed, vous êtes où? Si Mohamed, exprime-toi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Avant de vous passer une évaluation pour ce tissu-là.

Alors, vous avez des questions pour le tissu conjonctif ordinaire? Oui, bien sûr. Quelle est la différence entre les cellules macrophages et estiofibres? Alors, macrophages, c'est dans le sang. D'accord? C'est le même rôle, le même tout.

Et lorsqu'il traverse les capillaires et passe dans le tissu conjonctif ordinaire, il devient estiocite. Ça veut dire l'estiocite d'une macrophage tissulaire. Macrophage, c'est dans le sang.

Et lorsqu'il traverse, il devient tissulaire. Donc, qu'est-ce qu'on l'appelle? Estiocite. Donc, estiocite égale quoi? Macrophage tissulaire.

D'accord? Le même rôle, il phagocyte, il fait le rôle du macrophage, mais à l'intérieur du tissu. D'accord? Professeur, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Quelle est la différence entre cellules mésenchymateuses et mesoblastes? Et? Mesoblastes.

Donc, le mesoblaste égale mesenchyme. D'accord? Deux appellations. Soit on dérive de mesoblastes, soit ils dérivent de mesenchymes.

D'accord? C'est la même chose. Donc, mesoblastes embryonnaires, c'est les mesenchymes embryonnaires. D'accord? La même chose.

Oui, monsieur. La même chose. Il n'y a pas de différence.

Alors maintenant, on va faire une autre chose, une autre technique. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, bien sûr.

Alors entrez le code et vous écrivez maintenant. C'est à vous d'écrire. Oui? Monsieur, est-ce que les fibres de réticuline peuvent-elles s'anastomoser? Non.

Non. Donc, les fibres de réticuline, elles sont minces, fines. Elles ne s'anastomosent pas.

Elles ne se ramifient pas. Elles ne s'anastomosent pas. Elles ne se ramifient pas.

D'accord? Elles sont très minces. Alors, vous écrivez. Alors, citez les cellules fixes du tissu conjonctif ordinaire.

Il faut les citer, écrire dans vos téléphones. Allez, allez. Il y en a un seul qui a écrit.

Monsieur, s'il vous plaît, une question. Oui, beniti. Oui? Quelle est la différence entre le cytoplasme basophile et le cytoplasme embryonnaire? Alors, un cytoplasme, ça veut dire éosinophile.

Éosinophile, c'est acidophile. D'accord? C'est la même chose. Donc, acidophile, ça veut dire qu'est-ce qu'il aime? Acidophile, il aime quoi? Tout ce qui est acide.

D'accord? Il se colore bien avec des colorants acides. Et basophile, ça veut dire quoi? Il se colore bien avec des colorants qui sont basiques. D'accord? Généralement, il est acidophile.

Il est éosinophile. Il est un petit peu rose. Donc, c'est le cytoplasme qui est généralement acidophile.

Et le noyau, il est très basique parce qu'il comporte des nucléotides qui vont se fixer. Donc, acidophile égale éosinophile. D'accord? Il aime tout ce qui est acide.

Et basophile, ça veut dire qu'il est basique. Il aime tout ce qui est colorant basique. C'est le pH.

D'accord? pH acide, pH basique. Oui, merci monsieur. D'accord? Très bien.

Donc, vous avez tous... Donc, les réponses qui sortent beaucoup, elles vont afficher en gras. Très bien. Il y a fibroblastes, fibrocytes, adipocytes, cellules mesenchymateuses.

Donc, ça c'est les cellules fixes de tissus conjonctifs. Très bien. Donc, on a su l'adipose.

Oui, très bien. Donc, regardez qui reste en gras. C'est les réponses qui sont beaucoup écrites.

Donc, mesenchymateuses, fibroblastes, fibrocytes, adipocytes. Donc, regardez, ça c'est les cellules fixes. Alors, on passe.

Donc, vous m'écrivez les caractéristiques que je viens de dire pour les fibres de rétuculine. Vous citez les caractéristiques. Allez, vous écrivez dans vos téléphones.

Là, dans vos PC, quel que soit, vous êtes connecté. Alors, les caractéristiques des fibres de rétuculine. Oui.

Oh la la, anastomose. Oh la la, non ramifiée. Très bien.

Donc, fibrille de collagène. Très bien. Non ramifiée.

Grillagée. Très bien. Mince.

Très bien. Avec flexible mèche bête niche. Très bien.

Donc, qui sort mince. Très bien. Non ramifiée.

Très bien. Grillagée. C'est comme un grillage.

D'accord. L'origine, c'est une fibrille de collagène à laquelle on ajoute un complexe glucidique. Très bien.

Attachement de glucides. Donc, c'est le glucide là qui s'attache aux fibrilles de collagène qui empêchent qu'ils s'organisent en faisceaux. D'accord.

Ils ne s'organisent jamais en faisceaux. Ils ne s'anastomosent jamais. Ils ne se ramifient jamais.

D'accord. Très bien. Bravo.

Donc, ça, c'est les mots-clés du complexe glucidique. Non ramifiée. Grillagée.

Très bien. Non anastomosée. C'est les mots-clés du hybride réticulé.

Donc, à l'image de la mèche bête niche, le cartilage est là. On passe. Alors, citez les constitutions de tissus conjonctifs ordinaires.

Qu'est-ce que vous connaissez de constitution de tissus conjonctifs ordinaires ? Vous le mettez. Très bien. Matrice fondamentale.

Fibre. Substance fondamentale. Fibre de collagène.

Cellules mobiles autochtones. Cellules mobiles immigrées. Matrice extracellulaire.

Protéines d'adhérence. Cellules jointives. Cellules non jointives.

Attention, attention. Il est énervé. Il est vascularisé.

Donc, cellules fixes. Très bien. Qui a écrit, il peut réécrire encore.

C'est limité à une seule proposition. Vous pouvez écrire et réécrire et entrer. D'accord ? Très bien.

Donc, cellules fixes. Cellules non jointives. Fixe.

Matrice extracellulaire. Fibre. C'est une maison schémateuse.

Tout ça. Énervé. Vascularisé.

Très bien. Donc, c'est les différents termes qui sortent toujours. Matrice extracellulaire.

Fibre. Substance fondamentale. Protéines d'adhérence.

Cellules mobiles autochtones. Cellules mobiles immigrées. Vous pouvez.

Très bien. Bravo. Donc, je pense que le message est clair.

Il est net. Il n'y a pas de problème. Good.

Good, les amis. Good. Très bien.

Les types de tissus conjonctifs ordinaires. Donc, les types. Il y aura trois types.

Très bien. Dense, lâche et... Dense et fibreux. C'est la même chose.

Cellulaire. Très bien. Donc, en m'a qui vont sortir.

Dense et fibreux. La même chose. Dense et fibreux.

Donc, il n'y a pas un tissu conjonctif de type élastique. Ça n'existe pas. C'est les fibres qui sont de type élastique.

Ce n'est pas un tissu conjonctif ordinaire élastique. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, les termes qui sortent, voilà, qui restent en gras.

Lâche, cellulaire, dense. Lâche, cellulaire, dense. Dense et fibreux.

Donc, plus les réponses sont plus, ils vont de plus en plus sématiser en gras. D'accord? Donc, effectivement, lâche, c'est équilibre. Cellulaire, c'est les cellules qui vont gagner.

Dense, c'est les fibres qui vont gagner. Et fibreux, c'est les fibres aussi qui vont gagner. Donc, dense égale fibreux.

Très, très bien. Vous êtes excellent. Très, très, très bien.

Bravo, bravo, bravo. Alors, maintenant, citez les cellules mobiles du tissu conjonctif ordinaire. Les cellules mobiles, s'il vous plaît.

Cellules mobiles, ça veut dire que vous écrivez les cellules mobiles résidentes ou autochtones et immigrées. Allez, allez, très bien, très bien. Mastocyte, macrophage, leucocyte, histiocyte, très bien.

Cellules immigrées, globules blancs, très bien. Plasmocyte, monocyte, mastocyte, très bien. Alors, vous pouvez écrire et réécrire, écrire et réécrire.

Polynucléaire et usinophile, polynucléaire neutrophile, très bien. Très bien. Donc, je pense que le message est clair et net.

Vous avez bien saisi. Donc, on va le voir la prochaine fois. OK.

Est-ce que vous avez des questions? Allez, les amis. Oui, bien sûr. Les fibres de reticuline ne sont pas flexibles.

Est-ce qu'elles ne sont pas flexibles? Le terme, il faut différencier flexible d'élastique. D'accord? Comme les fibres de collagène, elles sont flexibles mais non élastiques. D'accord? Il ne faut pas, c'est flexible, un petit peu flexible, oui, mais pas autant qu'il soit élastique.

D'accord? Il ne faut pas dire que c'est flexible et élastique, d'accord? Ce n'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Oui, Salma.

Le mésenchyme, c'est le... Le mésenchyme, c'est le tissu conjonctif. Le mésenchyme est? Le tissu conjonctif. Malou.

C'est la même chose. Là, là. Donc, le mésenchyme, il est embryonnaire, il est jeune.

D'accord? Le mésenchyme, c'est des cellules mésenchymateuses qui peuvent donner le fibroblast et le fibroblast va synthétiser la matrice pour former le tissu conjonctif ordinaire. D'accord? Les cellules mésenchymateuses, on peut les stimuler pour former le chondroblast et donner le tissu cartilagineux. Les cellules mésenchymateuses, on peut les stimuler pour qu'elles donnent l'os.

Donc, les mésenchymateuses, c'est indifférenciées. D'accord? Et au cours du développement, elles vont se différencier. Ils peuvent se différencier de tissus mésenchymateux en tissu conjonctif ordinaire, de tissus mésenchymateux en tissu cartilagineux.

D'accord? Il est jeune. D'accord? Il n'est pas encore différencié. D'accord? Vous avez des questions? Oui, Binti? Pour les cellules mesenchymateuses, je n'ai pas bien compris la notion du petit poteau.

Ça veut dire, ça veut dire, regardez, vous avez une cellule mesenchymateuse. On ne sait pas ce qu'elle va donner. D'accord? Ça veut dire, la cellule mesenchymateuse, elle est là, elle attend un stimulus.

Soit elle va aller vers le chemin de tissu conjonctif ordinaire, soit elle va aller dans le chemin de tissu musculaire, soit elle va aller dans le chemin de tissu cartilagineux, soit elle va aller dans le chemin de tissu osseux, soit dans le chemin de tissu adipeux. Donc, il peut avoir plusieurs chemins. D'accord? D'accord, monsieur.

Oui? Monsieur? Oui, Woldi? D'abord, le tissu est pétérial et non vascularisé et non énérvé. Oui, Woldi. Mais pour les glandes endocrines, il y a des infos sur les artères.

Non, il y a des infos sur les cellules. Il y a des infos sur le tissu conjonctif qui le soutient. D'accord? Mais les cellules pétériales ne sont pas vascularisées.

D'accord? Mais le tissu conjonctif qui les soutient, c'est lui qui est vascularisé. D'accord? Le tissu épétérial, ce sont des cellules épétériales qui forment un tissu, un ensemble de cellules jointives juste opposées, quelles que soient épétériales ou glandulaires. C'est des cellules épétériales.

L'épétélium, on ne le trouve jamais seul. Lorsque vous entendez un épétélium, vous trouverez toujours qu'il y a un tissu conjonctif sous-jacent qui assure quoi? Le soutien, la protection, la nutrition, beaucoup de choses. D'accord? Et le tissu de soutien, c'est lui qui est vascularisé.

D'accord? Donc, l'épétélium, oui, ça veut dire vascularisé. Il n'y a pas d'artères à l'intérieur de l'épétélium. D'accord? Il n'y a pas de filets nerveux à l'intérieur de l'épétélium.

Même s'il y avait le traitement vascularisé non-énérvé. Mais bien sûr, vous-même, le tissu qui le soutient, il est vascularisé. Mais le son ne passe pas dans les cellules épétériales.

D'accord? C'est pour cela qu'on aura un intermédiaire lébinetôme qui est le tissu conjonctif. C'est pour cela que vous ne trouverez jamais un épétélium sans tissu conjonctif. D'accord? Donc, vous-même, les cellules épétériales ne sont pas vascularisées, ne sont pas énérvées, comme tissu.

Mais, ils reçoivent les nutriments, ils reçoivent tout ça à travers le tissu conjonctif sous-jacent. S'ils libèrent un produit endocrine, ils vont les libérer vers quoi? Vers les vaisseaux qui sont dans le tissu conjonctif. D'accord? D'accord, monsieur.

Monsieur, s'il vous plaît, je me demande la striation transversale lorsqu'on a parlé des fibres. Alors, les fibres de collagène, elles sont des striations. On m'a dit qu'il y avait une fibre comme

ça.

Il y a des striations comme ça. D'accord? Des striations transversales, des stris, des lignes. D'accord? Un endocrine est une fibre de collagène.

Une fibre d'élastique, il n'y a pas de striation. D'accord? Puisque la fibre de réticuline est une fibre de collagène, il y aura des striations transversales. C'est une fibre qui est comme ça avec des stris.

D'accord? Qui la traversent. Ce sont des stris qui se localisent de façon transversale de l'axe de la fibre. D'accord, merci.

Oui? Monsieur, s'il vous plaît? Oui, Réhan. Est-ce qu'on peut classer la membrane basale parmi, soit, le tissu fondamental ou bien le tissu conjonctif où elle reste neutre? Je connais, il y a la membrane basale. Oui.

La membrane basale, elle est formée des fibrilles, de quelques fibres de collagène, en particulierité des protéines d'adhérence, et des fibres. Donc, elle fait partie, généralement, du tissu conjonctif. D'accord? Parce qu'elle n'est faite que des fibres.

Elle a de la fibre, elle a de la membrane. Elle fait la séparation entre quoi et quoi? Entre l'hypothélium et le tissu conjonctif. Elle est formée de structures membranières, fibrilles, d'accord? La fibre, elle a l'aluminium, donc c'est une membrane basale qui est formée par des fibrilles qui sont particulières.

D'accord? Généralement, la membrane basale, elle a la même définition que le tissu conjonctif ordinaire, mais il n'y a pas de cellules, il n'y a que des fibres. D'accord? Donc, il fait partie du tissu conjonctif. Merci professeur.

C'est bon? Alors, la prochaine fois, on va terminer, je vais vous, je vais te poser le cours du tissu cartilagineux, d'accord? On va voir le tissu cartilagineux et le tissu et l'appareil circulatoire se forment des questions, aussi, comme ça, des quiz. Et après, lorsqu'on terminera les différentes semaines de développement embryonnaire, on va faire la même chose. comme Thomas, il faut, lorsqu'on a une séance interactive, il faut s'il vous plaît, réviser avant le cours.

Comme ça, ou je préfère que vous répondiez sans voir le support. Comme ça, vous jugez sur vos compétences et sur ce que vous avez retenu. D'accord? Donc, la semaine prochaine, on aura aussi le vendredi, on va faire une autre séance, on va terminer l'histologie.

D'accord? Je vais déposer le cours de l'appareil sur le tissu cartilagineux au niveau de support le lundi, d'accord? Le mardi. Et, la fin de la semaine, je vais déposer le reste de l'embryologie. D'accord? Donc, réviser.

Lorsque vous avez une séance interactive, c'est comme ça, c'est par question. D'accord?

D'accord? C'est bon? D'accord. Bien.

À la prochaine fois, incha Allah. Merci, merci. Merci professeur.

Bonne journée. Merci professeur. A bientôt.

Professeur, professeur, la prochaine, c'est, on va faire l'embryologie ou la liste? Non, on va faire la liste après. C'est deux chapitres. On va en profiter pour en profiter un peu, sinon on va faire l'appareil circulatoire et le tissu cartilagineux.

D'accord? les chapitres que je fais moi, d'accord, et les autres chapitres, vous le voyez avec le Docteur Hezmieri, d'accord ? D'accord, merci. Si on aura plus de temps, je vais faire même des quiz concernant les parties de... On laissera la révision finale, je vais projeter tout le programme. C'est pour cela, la dernière séance, je l'ai laissée jusqu'à la fin d'avril, jusqu'à le 22 avril, d'accord ? Comme ça, vous saurez tout le programme qui est fait, et je vais faire une révision globale de tous les cours que vous avez sous forme de quiz, d'accord ? D'accord, merci, merci.

Oui, Binti ? Monsieur, s'il vous plaît, les semaines de développement embryonnaire que vous avez déposées ? Il y a la première et la deuxième semaine. Oui, parce que... D'abord, ne cassez pas la tête. Vous le trouverez sous forme de vidéo sur Youtube.

Ne vous cassez pas la tête. C'est bon, d'accord, merci. D'accord ? Il y a le tissu cartilagine, il y a le tissu épithélial, il y a l'appareil circulatoire, il y a les différentes semaines de développement, il y a tout sur Youtube.

Ne vous cassez pas la tête. D'accord ? Vous mettez sur Youtube, maintenant je le dépose sur Youtube, je ne passe la tête, d'accord ? Vous filmez quelque chose, vous pouvez réviser, d'accord ? C'est bon ? Ne vous cassez pas la tête, c'est une autre plateforme. Passez directement sur Youtube, vous trouverez les cours, oui ? Monsieur, s'il vous plaît, dans une question, j'ai trouvé que la classification des glandes exocrines repose sur le mécanisme de vidange.

Ça veut dire quoi ? Alors, qui peut me dire mécanisme de vidange, c'est quoi ? Est-ce que c'est le mot de cette question ? Très bien. Mécanisme de vidange, comment il va vidanger, comment il va sécréter ? C'est la langue française, pure et dure. D'accord ? Mécanisme de vidange, également de sécrétion.

Mécanisme, c'est un mode, d'accord ? C'est bon ? Et pour la prochaine fois, vous préparez vos questions, d'accord ? Pour le vendredi prochain, révisez. Et si vous n'avez pas compris des choses, on peut la revoir, d'accord ? Les séances interactives, je peux faire ce que je veux, d'accord ? Le temps que vous savez simuler les choses, on arrêtera les séances interactives, d'accord ? D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, une question.

Oui, ben si. Monsieur, dans le cas où tout le tissu doré-vêtement est glandulaire, est-ce que pour

le nommer, on se base sur les critères de non-clature du tissu glandulaire, ainsi que celui des pétéliards doré-vêtements ? Là, de sécrétion, il est sécrétoire. Tous les pétéliards, ils sécrètent.

Tous les pétéliards doré-vêtements, ils sécrètent. La classification ne change pas, parce qu'il reste quoi ? Un pétéliard de quoi ? Doré-vêtement. Doré-vêtement, on le classe.

Mais chez nous, ZLC, tout simplement, il est sécrétoire, d'accord ? Mais il reste un pétéliard doré-vêtement. Est-ce qu'on cite la substance sécrétée ? Non, non, non, non, non. La classification ne change pas.

La classification, c'est une classification morphologique. Mais elle n'a pas de rapport avec le rôle qu'il sécrète, d'accord ? Vous voyez, il peut être sécrétoire avec une cylindrique simple, avec un cubique simple, avec un cubique cylindrique stratifié, mais il n'a pas de rapport. La classification des pétéliards doré-vêtements a un aspect morphologique, on voit.

Est-ce que vous voyez la sécrétion ? On ne voit pas la sécrétion, d'accord ? Menez-le au raisonnement, d'accord ? D'accord, merci. C'est bon ? Vous avez autre séance aujourd'hui ou là ? Non, professeur. D'accord, à bientôt, incha'Allah.

Merci, monsieur.